EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	73755
SERVICIO	:	CIRUGIA HSC			
FECHA	:	2023-11-08 10:11:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUISA ELIANA VALDIVIA MUNOZ			**RUN**	: 4.632.212-6
F.Nac	: 15-05-1940	**Edad**	: 83 AÑOS, 5 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: PUELMA 657			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-10-16	**Fecha Egreso**	: 2023-11-08 10:11:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. U07.2-CASO SOSPECHOSO O PROBABLE COVID-19

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Epicrisis de Alta.

Diagnosticos

-Neumonia Nosocomial tratada.
-----Proteus Mirabalis BLEE/Pseudomona aureginosa MS /Providencia stuartii MS
-Fecaloma Impactado, tratado
-Encefalopatia metabólica corregida : Hipernatremia corregida
-Diarrea Aguda resuelta.
-Infección SARSCOV2 Positivo 23/10/23 fuera de cuarentena, asintomatica.
-Demencia
-Dependencia Total / Institucionalizada / Estado de postracion
-HTA.
-Alteraciones inespecifica H Tiroideas.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Ingresa por cuadro de diarrea aguda que dentro de estudio se pesquiza Antigeno Covid positivo por lo que se ingresa para tratamiento.
COn cuadro de hipernatramia de 158 que revierte con hidratacion endovenosa y posteriormente enteral, durante este periodo con tratamiento ATB ceftriaxona + Metronidazol. No presentó clinica respiratoria.
Posteriormente a los 7 dias de ingresada con abundante tos humeda , febriculas , y dificultad respiratoria leve.
Se inicia tratamiento empirico con Meropenem y se toman cultivos se secrecion bronquial con resultados descritos. TAC torax con condensacion basal derecha compartible con neumonia nosocomial.
Se inicia tratamiento con Meropenem que completa por 7 dias y posteriormente con Ertapenem + Ciprofloxacino esquema de alta.
Excelente evolucion respiratoria , sin secreciones ni obstruccion bronquial ,TAC de control con importante resolucion de lesiones infecciosas.
Cursa con cuadro de vomitos de retencion secundario a fecaloma , se inicia manejo con proquineticos , lactulosa y fleet enema con buena respuesta.
Al dia 8/11/23 aafebril , sin dificultad respiratoria , deposiciones + , sin tos ni secreciones respiratorias , sin dolor .
Dentro de examenes fisico , laboratorio e imagenes sin cuadro infeccioso demostrable , pcr estacionaria con perfil tiroideo tsh alta 9 y t4L 1.6 por lo que se solicita HODOM para mantener control de paciente.

PLAN DE MANEJO:

Plan:
Control tiroideos y parametros inflamatorios por Hodom.
Control SOS en Urgencias
Controles habituales en programa postrados CESFAM

INDICACIONES AL ALTA

1. Indicaciones
2. -Regimen habitual
3. -Reposo habitual. Retormar rutina diaria.
4. -Metoclopramida 10mg cada 12 horas por 3 dias
5. -Tratamiento cronico habitual. (no hay antecedentes de tratamiento en nuestro sistema)

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-N

JEFE SERVICIO